

Changement majeur dans la prise en charge de l'asthme

Dre LEILA AKHMETOVA^a, Dre RITA CUCCHIARA^a, Dr FLORIAN CHARBONNIER^b, Pre JOHANNA SOMMER^c et Dr JULIEN SALAMUN^a

Rev Med Suisse 2022; 18: 1788-91 | DOI : 10.53738/REVMED.2022.18.797.1788

Selon les nouvelles recommandations, il n'y a plus de place pour l'utilisation des bêta-agonistes à courte durée d'action seuls dans le traitement de l'asthme chronique, en raison d'un risque accru d'exacerbations sévères et de mortalité. La prise en charge actuelle se base sur l'utilisation combinée de corticostéroïdes inhalés et de formotérol en traitement de fond mais également en traitement de secours, grâce à l'action à la fois rapide et prolongée du formotérol. Le/la généraliste doit évaluer, avec la collaboration du/de la patient-e, les facteurs modifiables liés au mauvais contrôle de l'asthme et lui fournir un plan de traitement afin qu'il/elle puisse reconnaître et gérer les symptômes d'une exacerbation d'asthme. La place du/de la spécialiste est réservée aux stades avancés de la maladie et en cas de doute lors de la pose du diagnostic.

Major change in asthma management

According to the latest recommendations, there is no longer place for the use of short-acting beta-2 agonist alone in chronic asthma treatment, due to an increased risk of severe exacerbations and exacerbation-related mortality. Current management of asthma is based on the use of inhaled corticosteroids in combination with formoterol as maintenance and as rescue treatment, thanks to the rapid and prolonged action of formoterol. General practitioners must evaluate, with the patient's collaboration, the treatable factors linked to poor asthma control. They should provide patients with a written treatment plan in order to help patients recognize and manage asthma exacerbation. The place of the pulmonary specialist is currently reserved for the advanced stages of the disease and in case of diagnostic doubt.

NOUVEAUTÉS

L'asthme est une maladie inflammatoire chronique qui a touché, en 2019, plus de 260 millions de personnes dans le monde entier.¹ Sa prise en charge est régulièrement mise à jour par les sociétés savantes et d'importants changements ont été apportés dans la dernière mise à jour de GINA (Global Initiative for Asthma) en 2021.

Le plus important changement concerne l'utilisation des corticostéroïdes inhalés (CSI) dès le diagnostic de l'asthme, en association avec le formotérol, en traitement de fond ainsi

qu'en traitement de réserve, laissant la place aux bêta2-mimétiques à courte durée d'action (SABA, Short-Acting Beta2-Agonist) uniquement dans le cas d'une crise aiguë d'asthme, ou dans le traitement alternatif chez les patient-e-s ayant très peu d'exacerbations et ne souhaitant pas de changement de traitement.¹

Il est important de noter que la classification de la sévérité de l'asthme est fondamentale, car elle permet d'adapter le traitement de manière proportionnelle au degré de sévérité de la maladie. En pratique clinique, au moment du diagnostic, cette évaluation est basée sur les symptômes rapportés par les patient-e-s ainsi que les valeurs des fonctions pulmonaires. Chez les patient-e-s déjà suivi-e-s, cette évaluation se fait rétrospectivement à chaque consultation en considérant le niveau des traitements qui ont été nécessaires pour soulager les symptômes et contrôler les exacerbations.² Ces paramètres sont susceptibles d'évoluer constamment dès la pose du diagnostic et impliquent une bonne connaissance de la maladie de la part du/de la patient-e afin d'adapter son traitement.

Selon l'actuelle classification proposée par GINA,¹ on peut distinguer l'asthme léger, modéré et sévère. Néanmoins, l'asthme léger ne se divise plus en sous-types, tels que l'asthme intermittent et l'asthme léger persistant. En effet, cette distinction était basée sur l'hypothèse non vérifiée selon laquelle les patient-e-s présentant des symptômes 2 fois par semaine ou moins ne bénéficieraient pas du traitement par CSI. Or, les patient-e-s souffrant d'asthme léger sont toujours à risque d'une évolution défavorable compte tenu du fait que les facteurs déclencheurs (infections virales, pollens, non-observance, pollution d'air) peuvent être imprévisibles.

Le changement majeur de paradigme concerne donc la mise en place d'un traitement combiné de CSI en association avec le formotérol, à utiliser comme traitement de réserve pour l'asthme léger et comme traitement de fond et de réserve pour tous les autres stades de la maladie.¹

Le choix du formotérol comme bêta2-mimétique à longue durée d'action (LABA, Long-Acting Beta2-Agonist), en association aux CSI, est basé sur le fait que cette molécule n'a pas seulement une longue durée d'action mais également une action rapide,³ ce qui permet de l'utiliser efficacement comme traitement de secours.

REVUE 2022

Cette modification dans le traitement de première ligne de l'asthme repose sur des données validées entre autres par le

^aService de médecine de premier recours, Hôpitaux universitaires de Genève, 1211 Genève 14, ^bService de pneumologie, Hôpitaux universitaires de Genève, 1211 Genève 14, ^cInstitut universitaire de médecine de famille et de l'enfance, Université de Genève, 1211 Genève 4
leila.akhmetova@hcuge.ch | rita.cucchiara@hcuge.ch | florian.charbonnier@hcuge.ch
johanna.sommer@unige.ch | julien.salamun@hcuge.ch

programme SABINA.⁴ Il s'agit d'une étude rétrospective, menée à l'échelle mondiale, ayant comparé les différents traitements utilisés pour l'asthme et comme objectif final le bon contrôle des symptômes de la maladie, avec une réduction des exacerbations et des complications.

À l'issue de cette étude, il a été démontré qu'une utilisation excessive de SABA peut entraîner une augmentation du risque d'exacerbations sévères et de la mortalité; au contraire, l'utilisation précoce d'un CSI associé au formotérol permet un bon contrôle des symptômes tout en ayant un bon profil de sécurité sur l'utilisation à court et long termes.

L'étude a démontré que les SABA soulagent rapidement les symptômes mais, au contraire des corticoïdes inhalés, n'agissent pas sur l'inflammation qui est à la base de la maladie. Par ailleurs, il a été prouvé également qu'un excès d'utilisation de SABA favorise une réduction de l'expression des récepteurs B₂, entraînant sur le long terme une augmentation de la réactivité bronchique avec risque accru d'exacerbations sévères et

potentiellement mortelles. C'est entre autres sur la base de ces considérations qu'a été recommandée l'utilisation d'un CSI associé au formotérol dès le diagnostic initial d'asthme.

Dans l'asthme léger, on propose initialement l'association formotérol/CSI faiblement dosés en réserve. En fonction de la fréquence des symptômes, cela peut être instauré comme traitement de fond et de réserve, toujours au dosage inférieur. Dans l'asthme modéré, l'association formotérol/CSI est prescrite comme traitement de fond ainsi qu'au besoin. La dose de CSI peut ainsi être augmentée selon les symptômes.

En cas d'asthme sévère le/la patient-e devrait être référé-e au spécialiste afin d'évaluer l'ajout d'un traitement personnalisé en fonction des symptômes et des caractéristiques spécifiques de sa maladie, ouvrant la possibilité à la mise en place de traitements biologiques pour certaines formes sévères¹ (figure 1).

Avant d'augmenter les doses, il est toutefois crucial de faire une distinction entre asthme sévère et asthme mal contrôlé,⁵

FIG 1 Traitement chronique de l'asthme

Le schéma, repris des stratégies SMPR (Service de médecine de premier recours), représente l'approche par paliers pour le contrôle au long cours de l'asthme.

Formulations de budésonide et formotérol disponibles en Suisse: 100/6 µg; 200/6 µg; 400/12 µg

Une dose journalière de budésonide entre 200 et 400 µg est considérée comme faible, entre 400 et 800 µg elle est considérée comme moyenne et si supérieure à 800 µg comme élevée.

Formulations de bécloéthasone et formotérol disponibles en Suisse: 100/6 µg

Une dose journalière de bécloéthasone entre 100 et 200 µg est considérée comme faible, entre 200 et 400 µg elle est considérée comme moyenne et si supérieure à 400 µg comme élevée.

Formulations de fluticasone et formotérol disponibles en Suisse: 50/5 µg; 125/5 µg

Une dose journalière de fluticasone entre 100 et 250 µg est considérée comme faible, entre 250 et 500 µg elle est considérée comme moyenne et si supérieure à 500 µg comme élevée.

^aÉviter de passer à un palier inférieur chez la femme enceinte.

CSI: corticostéroïdes inhalés; GCS: glucocorticoïdes systémiques; LAMA: Long-Acting Muscarinic Antagonist.

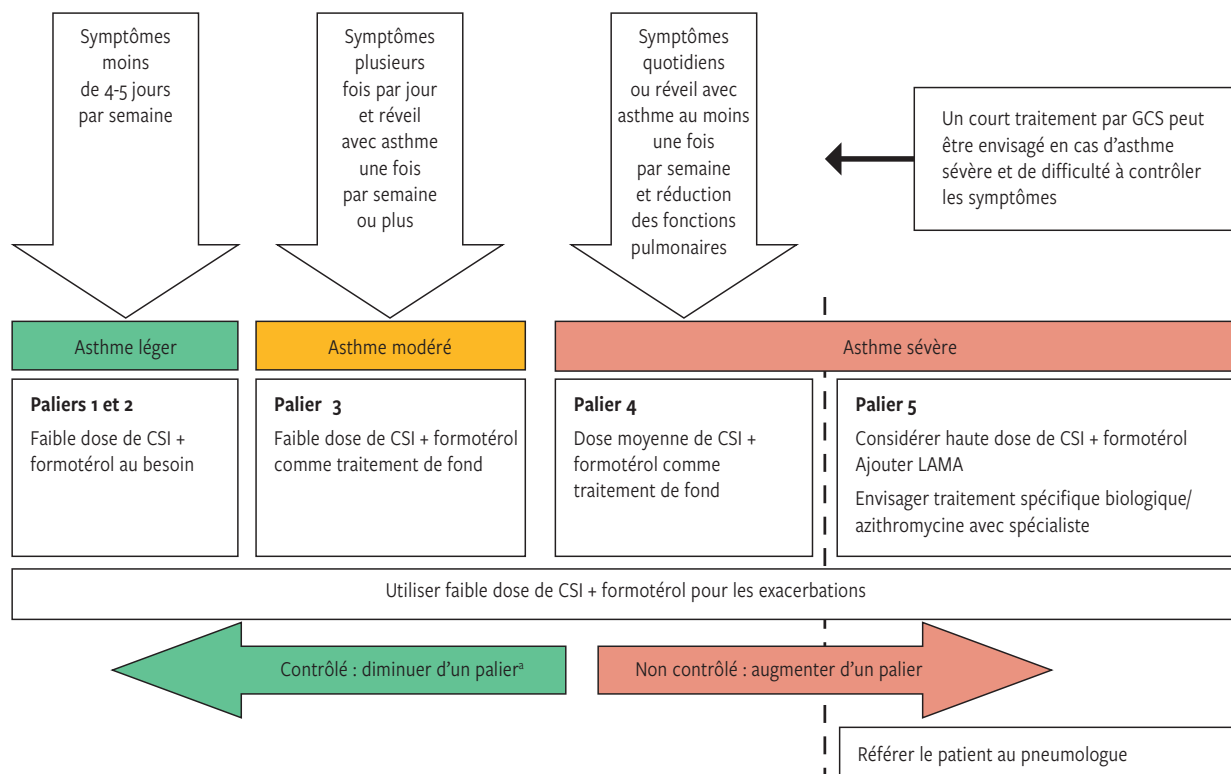
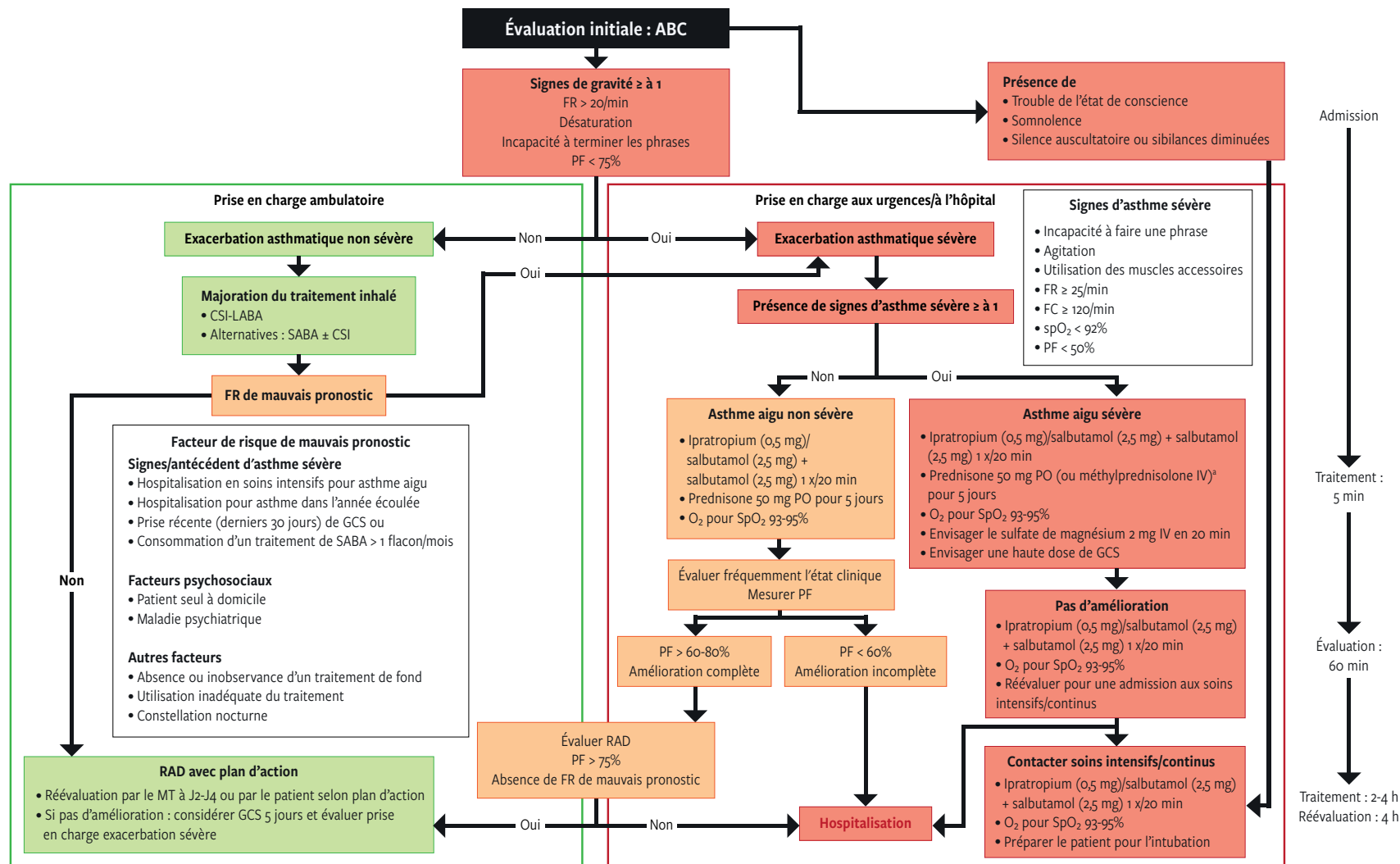


FIG 2 Algorithme de prise en charge de la crise d'asthme (repris des stratégies SMPR (Service de médecine de premier recours) de l'asthme)

^aPas de supériorité du traitement IV vs PO; seule indication: pas de prise PO possible.

ABC: Airways (voies aériennes libres), Breathing (respiration), circulation; CSI: corticostéroïdes inhalés; FC: fréquence cardiaque; FR: fréquence respiratoire; GCS: glucocorticoïdes systémiques; LABA: Long-Acting Beta2-Agonist (bêta2-mimétique à longue durée d'action); MT: médecin traitant; PF: peakflow; RAD: retour à domicile; SABA: Short-Acting Beta2-Agonist (bêta2-mimétique à courte durée d'action); SpO₂: saturation sanguine en oxygène.



ce dernier étant souvent dû à de mauvaises utilisation des dispositifs d'inhalation et adhérence au traitement prescrit ainsi qu'à un contrôle des facteurs déclencheurs inadéquat.

Au vu de ces considérations, afin de garantir une prise en charge optimale de la maladie, le/la médecin généraliste devrait vérifier avec le/la patient-e sa technique d'inhalation, la prise correcte des traitements, et promouvoir la prise en charge des facteurs modifiables⁶ (par exemple, l'apprentissage des techniques d'inhalation, la perte de poids pour les personnes obèses, l'augmentation de l'activité physique, les mesures d'hygiène et la vaccination pour réduire les crises d'asthme liées aux infections respiratoires, etc.).

Une place importante dans la prise en charge de l'asthme est attribuée à l'autoévaluation des symptômes, afin de permettre l'adaptation du traitement de fond. Comme outils, nous disposons actuellement de plusieurs questionnaires, dont, par exemple, l'Asthma Control Questionnaire (ACQ)⁷ ou l'Asthma Control Test (ACT)⁸. Ainsi, cela permet à travers des simples questions au/à la patient-e de dresser un bilan de sa maladie et de pouvoir en informer son médecin, qui prescrit le traitement le plus adapté.

Il est nécessaire pour le médecin traitant de donner au/à la patient-e un plan de traitement d'urgence écrit, expliquant les symptômes d'une crise d'asthme aigu et la prise en charge d'urgence en fonction des symptômes.¹ Le/la patient-e et son entourage devraient connaître les critères de gravité afin de savoir s'il faut se rendre d'urgence à l'hôpital ou s'il est suffisant d'ajouter à son traitement des corticostéroïdes oraux et contacter le médecin traitant pour la suite de la prise en charge dans les 48 heures à son cabinet (figure 2).

APPLICATION AU CABINET

La prise en charge de l'asthme est principalement du ressort du médecin généraliste. Au cabinet, en cas de mauvais contrôle, il faut toujours explorer le degré de compréhension de la maladie, vérifier les techniques d'inhalation et discuter des facteurs déclencheurs avant d'adapter le traitement.

Il est important de proposer un plan de traitement d'urgence avec des possibilités d'ajustement de traitement par le/la patient-e lors de maladie mal contrôlée, en prévoyant dans ces cas un contrôle médical dans les 2 à 5 jours.

L'envoi vers le spécialiste devrait être limité aux formes sévères et en cas de doute lors de la pose du diagnostic.

LIMITATIONS ET PERSPECTIVES

Malgré des données cliniques claires concernant la supériorité du traitement par CSI et formotérol et les risques liés à l'utilisation prolongée de SABA seuls, beaucoup de patient-e-s pourraient encore se retrouver avec ce traitement qu'ils ont utilisé depuis des décennies. Le travail des médecins généralistes sera crucial, en diffusant l'information aux patient-e-s, en leur expliquant les risques encourus au long cours pour faire changer leurs habitudes. Finalement, le coût et la disponibilité du traitement combiné ajouteront peut-être une barrière au changement, notamment dans les populations vulnérables. Un programme pédagogique aux échelles nationale et mondiale serait une option afin de sensibiliser la population à ces nouveautés.

Conflit d'intérêts: Les auteurs n'ont déclaré aucun conflit d'intérêts en relation avec cet article.

IMPLICATIONS PRATIQUES

- Le traitement de base de l'asthme, de fond comme de réserve, doit comprendre un corticostéroïde inhalé et le formotérol
- Le salbutamol n'a plus de place en première intention dans le traitement chronique, en dehors d'une crise d'asthme aigu
- L'asthme est une pathologie gérée majoritairement par les généralistes, et seuls les cas les plus compliqués sont adressés aux spécialistes

1 **Global Initiative For Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021, (en ligne). www.ginasthma.org

2 Reddel HK, Taylor DR, Bateman ED, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: asthma control and exacerbations: standardizing endpoints for clinical asthma trials and clinical practice. *Am J Respir Crit Care Med*. 2009;180:59-99.

3 Anderson GP. Formoterol: pharmaco-

logy, molecular basis of agonism, and mechanism of long duration of a highly potent and selective beta 2-adrenoceptor agonist bronchodilator. *Life Sci*. 1993;52:2145-60. DOI: 10.1016/0024-3205(93)90729-m.

4 **Nwaru BI, Ekstrom M, Hasvold P, et al. Overuse of short-acting β_2 -agonists in asthma is associated with increased risk of exacerbation and mortality: a nationwide cohort study of the global SABINA programme. *Eur Respir J*.

2020;55:1901872.

5 Reddel H, Ware S, Marks G. Differences between asthma exacerbations and poor asthma control. *Lancet*. 1999;353:364-9.

6 McCoy K, Shade DM, Irvin CG, et al. Predicting episodes of poor asthma control in treated patients with asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 2006;118:1226-33.

7 Meltzer EO, Busse WW, Wenzel SE, et al. Use of the Asthma Control Questionnaire to predict future risk of

asthma exacerbation. *J Allergy Clin Immunol*. 2011;127:167-72.

8 *Thomas M, Kay S, Pike J, et al. The Asthma Control Test (ACT) as a predictor of GINA guideline-defined asthma control: analysis of a multinational cross-sectional survey. *Prim Care Resp J*. 2014;23:79-84.

* à lire

** à lire absolument